



ANNALES OFFICIELLES EVC

EVCF 2019

Épreuve de vérification des connaissances fondamentales

Médecine générale (code 71)

SUJETS

4

QUESTIONS

31

SUJET

01

Cas clinique · 6 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Un patient de 82 ans consulte pour dyspnée. Le patient est pâle. L'examen cardiopulmonaire est normal hormis une tachycardie. L'hémogramme (normal six mois auparavant) est le suivant : Hb 8,1 g/dL, plaquettes 180 giga/L, leucocytes 7,15 giga/L, polynucléaires neutrophiles 4,8 giga/L, polynucléaires éosinophiles 0,25 giga/L, polynucléaires basophiles 0 giga/L, lymphocytes 1,8 giga/L, monocytes 0,3 G/L.

1

QUESTION 1

Quel élément essentiel est manquant pour interpréter cette anémie ?

2

QUESTION 2

L'anémie est macrocytaire. Quel paramètre biologique est nécessaire pour caractériser cette anémie et comment l'interprétez-vous en précisant la valeur seuil ?

3

QUESTION 3

Citez les principales causes d'anémie macrocytaire en les classant selon leur mécanisme.

4

QUESTION 4

Si l'ensemble des examens sanguins demandés sont normaux, quel est l'examen qui s'impose à visée diagnostique ?

5

QUESTION 5

Si à l'examen, vous mettez en évidence un subictère conjonctival et un débord splénique à deux travers de doigt en inspiration profonde, quel mécanisme suspectez-vous ?

6

QUESTION 6

Quelles anomalies biologiques le confirmeraient ?

SUJET

02

Cas clinique · 7 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Une femme 37 ans se présente chez son médecin généraliste, dans le cadre de son suivi. Antécédents : Surcharge pondérale, I.M.C = 31 Tabagisme actif Trouble de l'humeur : avec un suivi en Centre médico-psychologique par un psychiatre depuis une dizaine d'années, stabilisé depuis 3 ans Traitement habituel : Quetiapine 400mg LP : 0.0.1 Zopiclone 7,5mg : 0.0.0.1 Alprazolam 0,5mg : 1.1.1

1

QUESTION 1

Formule de l'Indice de Masse Corporelle, précisez les unités

2

QUESTION 2

Donnez les critères de classification de l'I.M.C d'après l'OMS, citez les différentes tranches

3

QUESTION 3

A quels traitements adjuvants devez-vous penser au vue du traitement psychotrope de la patiente. Citez-en 2

4

QUESTION 4

Selon les recommandations de l'H.A.S en vigueur, au vue de son traitement, quelles surveillances clinique et paraclinique proposez-vous pour cette patiente, pourquoi ?

5

QUESTION 5

La patiente vous demande une contraception, quelles sont vos propositions?

6

QUESTION 6

Quels sont les autres conseils de prévention que vous pouvez proposer à cette patiente, dans ce contexte? Citez en 3.

7

QUESTION 7

Dans le cadre du renouvellement de son traitement, précisez les durées de prescriptions réglementaires pour les molécules suivantes Alprazolam : Zopiclone :

SUJET

03

Cas clinique · 7 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Un patient de 45 ans, fumeur (30 paquets-années) vient consulter pour un état nauséeux et quelques vomissements depuis 3 jours. Dans ses antécédents, on retient principalement un syndrome dépressif efficacement traité par Paroxétine 40 mg par jour depuis 2 mois. Il ne prend pas d'autres traitements. Il ne consomme pas d'alcool. A l'examen clinique, vous notez une perte de poids de 3 kilos en 2 mois. Il pèse 65 kilos pour 1m70. Il est apyrétique. La pression artérielle est à 130/80 mmHg, le pouls à 78 battements/mn. Il n'y a pas de pli cutané, pas d'œdèmes. L'abdomen est souple et non douloureux. L'auscultation thoracique est normale. Vous recevez quelques heures plus tard le résultat d'un bilan biologique : leucocytes 9800/mm³, Hb : 14,5g /dl, plaquettes : 250 000/mm³, Natrémie : 123 mmol/L, Kaliémie : 3,6 mmol/L, urémie : 4 mmol/L, créatininémie : 65 µmol/L, glycémie 5,7 mmol/L à jeun. Protidémie à 65 g/L.

1

QUESTION 1

Quelle(s) anomalie(s) biologiques(s) relevez-vous ?

2

QUESTION 2

Comment qualifiez-vous son état d'hydratation ?

3

QUESTION 3

Quels pourraient en être les signes de gravité clinique ?

4

QUESTION 4

Quel est l'examen biologique clé à ce stade de votre raisonnement ?

5

QUESTION 5

Quel mécanisme suspectez-vous pour expliquer l'anomalie biologique principale ?

6

QUESTION 6

Citez sans justifier les deux hypothèses diagnostiques les plus probables chez ce patient.

7

QUESTION 7

Quels sont les principes généraux du traitement chez ce patient ?

SUJET

04

Cas clinique · 11 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Monsieur P., 72 ans, est suivi pour un cancer du sigmoïde pour lequel il a été opéré il y a 2 ans et a eu une chimiothérapie. Monsieur P., arrive dans votre service de médecine polyvalente pour un tableau d'altération de l'état général avec perte d'appétit, évoluant depuis plusieurs semaines. Son poids est de 65kg pour 1m75m, le patient a perdu 10kg en mois. Il se plaint d'une importante douleur lombosacrée qui irradie dans le membre inférieur droit et qui est apparue il y a 3 semaines et qui résiste au traitement antalgique qui comporte une association paracétamol -codéïne.

1

QUESTION 1

Quelles sont les 2 grands types de douleur chez ce patient ?

2

QUESTION 2

Quelles sont les deux types d'échelle utilisées pour évaluer l'intensité de la douleur ?

3

QUESTION 3

Citez une échelle de chaque type utilisable chez l'adulte

4

QUESTION 4

Quel est le principal eff et secondaire de la morphine ?

5

QUESTION 5

Citez 3 autres eff ets secondaires des morphiniques ?

6

QUESTION 6

Quels sont les signes de surdosage des traitements opioïdes forts ?

7

QUESTION 7

Quel est l'antidote des morphiniques ?

8

QUESTION 8

Citez 2 classes thérapeutiques utilisées par voie générale contre les douleurs neuropathiques ?

9

QUESTION 9

Si le patient adulte est hors d'état d'exprimer sa volonté, (cochez la bonne réponse)

PROPOSITIONS · cochez VRAI ou FAUX

- ☐ V ☐ F La personne de confiance est la personne à prévenir
☐ V ☐ F le médecin traitant peut être désigné personne de confiance

10

QUESTION 10

Les directives anticipées (cochez la bonne réponse)

PROPOSITIONS · cochez VRAI ou FAUX

- ☐ V ☐ F Si les directives anticipées sont adaptées à la situation du patient, le médecin est obligé de les respecter
☐ V ☐ F Les directives anticipées ont une durée de validité de 3 ans

11

QUESTION 11

Quels sont les 3 critères indispensables pour pouvoir réaliser une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès ?